

DOLORCONCIENCIA

Protocolo 14 Días

Rodilla y Cadera

El método con aval científico que en 15 minutos al día cambia cómo tu cuerpo procesa el dolor.

· SOLTAR ·

· FORTALECER ·

· INTEGRAR ·

14 días · 4 perfiles de dolor · Perfil personalizado

Para cualquier profesión · Desde casa · Sin aparatos

DolorConCiencia

Bióloga en formación · UNLpam

Este material es educativo y no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional. Consultá a tu médico o fisioterapeuta antes de iniciar cualquier programa de ejercicios.

Bienvenida

Antes de empezar — leé esto

Si llegaste hasta acá, probablemente ya conocés esa sensación: la rodilla que avisa al subir escaleras, la cadera que se traba después de estar mucho tiempo sentada, el dolor que aparece sin que te hayas lastimado en nada puntual.

Soy bióloga en formación. Estudié años cómo aprende el sistema nervioso —y cómo, a veces, aprende mal a sostener el dolor. Lo que vas a encontrar acá no es una rutina genérica de "ejercicios para rodilla": es el mismo principio que ya usamos en espalda y cuello, aplicado a tu cadera y tu rodilla con la evidencia específica de esa zona.

Una aclaración importante antes de arrancar: tu rodilla o tu cadera no son solo cartílago. La ciencia muestra que el daño que aparece en una resonancia casi nunca explica por sí solo cuánto dolor sentís. El sistema nervioso tiene un rol central —y eso es exactamente lo que vamos a trabajar, sin reemplazar nunca el seguimiento de tu médico.

Bienvenida.

— María José · Bióloga en formación · DolorConCiencia

Señales de alarma

Leé esto antes de empezar. Este programa es seguro para la gran mayoría de las personas con dolor crónico de rodilla y cadera. Sin embargo, hay síntomas que requieren atención médica antes de hacer cualquier ejercicio.

PARÁ Y CONSULTÁ URGENTE SI TENÉS:

- La rodilla o la cadera “se va”, cede o no soporta el peso de golpe
- Bloqueo articular (la rodilla se traba y no podés estirla o flexionarla)
- Hinchazón aguda con calor y enrojecimiento intensos
- Fiebre junto con dolor e hinchazón articular
- Dolor, hinchazón o calor en la pantorrilla
- Imposibilidad de apoyar el peso después de un golpe o caída

CONSULTÁ ANTES DE EMPEZAR SI TENÉS:

- Cirugía de rodilla o cadera reciente sin el alta médica
- Fractura diagnosticada que no consolidó todavía
- Prótesis colocada recientemente
- Inestabilidad articular diagnosticada

Este programa ES para vos si:

- ✓ Tenés dolor crónico de rodilla o cadera (más de 3 meses) sin señales de alarma.
- ✓ Te diagnosticaron artrosis, tendinopatía o “desgaste” y el dolor no calma con reposo.
- ✓ Evitás movimientos por miedo a lastimarte, más que por dolor agudo real.
- ✓ Querés entender por qué duele, no solo recibir una rutina de ejercicios.

Este programa es educativo y de acompañamiento. No diagnostica ni reemplaza la consulta médica o kinesiológica. Si tenés dudas sobre tu caso particular, consultá a un profesional de la salud.

Tu perfil de dolor — antes de empezar

Respondé honestamente. No hay respuestas correctas — el objetivo es que el programa se ajuste a tu caso. Marcá la opción que más se acerque a tu situación actual en cada pregunta.

PREGUNTA 1

¿Dónde sentís el dolor con más frecuencia?

Adelante de la rodilla (rótula)
Ingle o parte delantera de la cadera

Costado o por dentro de la rodilla
Costado de la cadera

PREGUNTA 2

¿Hace cuánto tenés este dolor?

Va y viene desde hace mucho
6 meses a 1 año

3 a 6 meses
Más de 1 año

PREGUNTA 3

¿Qué lo empeora?

Subir o bajar escaleras
Correr, saltar o actividad de impacto

Estar mucho tiempo sentada o de pie
Acostarme de un lado o cruzar las piernas

PREGUNTA 4

¿Te diagnosticaron algo en estudios?

Sí, artrosis o desgaste
No me hice estudios

Sí, algo en un tendón o ligamento
Sí, pero no explica todo el dolor

PREGUNTA 5

¿Qué esperás de este programa?

Eliminar el dolor completamente
Entender por qué tengo dolor

Reducirlo a un nivel manejable
Todo lo anterior

Qué dicen tus respuestas

Identificá el perfil que más se parece a tu caso. Podés tener rasgos de más de uno: elegí el que predomine.

A Perfil A — Rodilla anterior, activa

Dolor adelante de la rótula, empeora con escaleras o sentadillas, sin diagnóstico de desgaste necesariamente. Tu eje principal es reducir el miedo al movimiento. Prestá especial atención a la Fase 1 y a los ejercicios de cuádriceps y glúteo.

B Perfil B — Rodilla tipo artrosis

Diagnóstico de artrosis con dolor que no siempre corresponde a la gravedad de ese diagnóstico. Tu sistema nervioso está sosteniendo parte del dolor. Foco en educación y fortalecimiento progresivo de cuádriceps.

C Perfil C — Cadera anterior / ingle

Mismo mecanismo que el Perfil B, en cadera. Foco en fortalecimiento progresivo y movilidad.

D Perfil D — Cadera lateral

Lo más probable no es la articulación, es el tendón del glúteo. En tu caso la Fase 1 va a ser más conservadora: evitá impacto y estiramientos profundos de cadera hasta la Fase 2.

FASE 1

La Base

Días 1 a 3

Empezamos donde todo comienza: el sistema nervioso. Antes de fortalecer, necesitamos que el cerebro aprenda a moverse sin miedo y que la zona recupere control básico, sin carga.

En esta fase:

- Día 1 — El reset
- Día 2 — Desactivar la alarma de la cadera
- Día 3 — La base de tu rodilla y cadera



DÍA 1

El reset

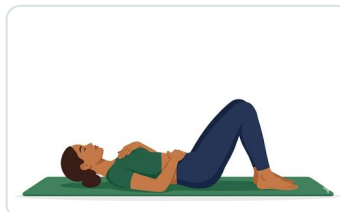
Respiración y presencia · 15 minutos

El dolor crónico de rodilla y cadera involucra sensibilización central: el sistema nervioso aprende a enviar señales de alarma incluso sin daño nuevo. La respiración diafragmática activa el sistema parasimpático y reduce esa alarma.

EJERCICIOS

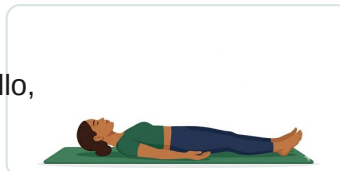
01 Respiración diafragmática.

Acostada boca arriba, rodillas dobladas. Una mano en el pecho, otra en el abdomen. Inhalá 4 segundos llevando el aire al abdomen, exhalá 6 segundos. 8 ciclos.



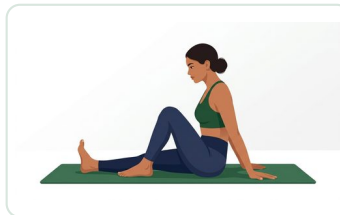
02 Escaneo de pierna completa.

Seguís acostada, ojos cerrados. Llevá la atención al pie, después tobillo, rodilla, cadera -sin intentar cambiar nada, solo observar. 3 minutos.



03 Activación isométrica de cuádriceps.

Sentada con la pierna estirada, contraé el músculo de adelante del muslo presionando la rodilla hacia abajo, sin mover la pierna. 10 contracciones de 5 segundos.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

Si no sentís dónde activar el cuádriceps, apoyá la mano sobre el muslo -sentir la contracción ayuda a aprenderla más rápido.

DÍA 2

Desactivar la alarma de la cadera

Movilidad suave de cadera · 15 minutos

El glúteo medio y los flexores de cadera suelen quedar en alerta constante en el dolor crónico. Si tu perfil es D (cadera lateral), esta fase evita rangos profundos a propósito: el objetivo es bajar la sensibilidad, no estirar al límite.

EJERCICIOS

01 Respiración 4-4-6.

Inhalá 4 segundos, retené 4, exhalá 6. 8 ciclos, antes de cualquier actividad del día.



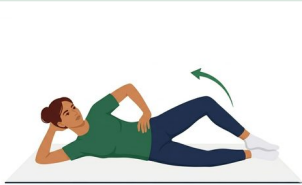
02 Movilidad de cadera sentada.

Sentada, rodillas separadas al ancho de cadera, hacé círculos suaves con las rodillas hacia afuera y adentro. 10 por lado, sin forzar.



03 Isométrico de glúteo medio acostada.

De costado, rodillas levemente flexionadas, levantá la rodilla de arriba unos centímetros sin rotar la cadera. Sostené 5 segundos. 10 repeticiones por lado.



SI TENÉS PERFIL D (CADERA LATERAL)

Hacé este ejercicio con un rango chico -la idea es activar el músculo, no llegar lejos. Trabajá con mucha menos intensidad que en el resto de los ejercicios del día, y si aparece dolor, frená.

DÍA 3

La base de tu rodilla y cadera

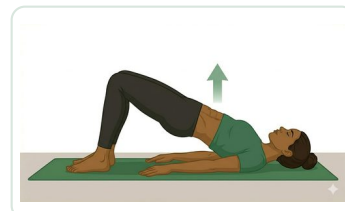
Control motor inicial · 15 minutos

La pérdida de control motor en cadera y rodilla es muy común en el dolor crónico. Estos ejercicios reeducan el patrón básico de movimiento, sin carga compresiva sobre la articulación.

EJERCICIOS

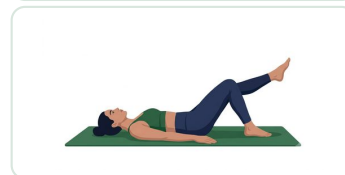
01 Puente de glúteo.

Acostada, rodillas dobladas, pies apoyados. Levantá la cadera apretando glúteos, sin arquear la espalda baja. 10 repeticiones, 3 segundos arriba.



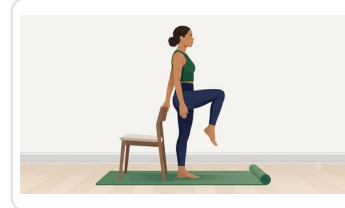
02 Elevación de pierna recta.

Acostada, una rodilla doblada y la otra estirada. Levantá la pierna estirada unos 30 cm, sin que la cadera se mueva. 10 por lado.



03 Marcha consciente en el lugar.

De pie, sostenida si necesitás apoyo, levantá las rodillas alternadamente de forma lenta, sintiendo cómo se activa cada pierna. 1 minuto.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

La calidad del movimiento importa más que la cantidad de repeticiones en esta fase.

FASE 2

La Reconstrucción

Días 4 a 10

Ya tenés la base. Ahora construimos fuerza real y progresión de carga. El cuádriceps y el glúteo medio son, según la evidencia, los músculos con mayor impacto en reducir el dolor de rodilla y cadera.

En esta fase:

- Día 4 — Encender el motor
- Día 5 — El puente fuerte
- Día 6 — Paso firme
- Día 7 — Mirá lo que construiste
- Día 8 — La potencia
- Día 9 — Cadena completa
- Día 10 — Resistencia funcional

2

DÍA 4

Encender el motor

Fuerza inicial · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Sentadilla parcial apoyada.

Con apoyo de una silla o pared, baja hasta donde te sientas cómoda, sin pasar de un cuarto de sentadilla. 10 repeticiones.



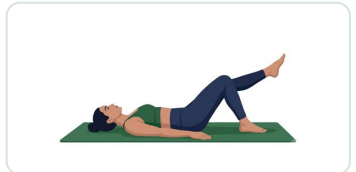
02 Puente de glúteo con pausa.

Igual que el Día 3, pero sostené 3 segundos en el punto más alto. 12 repeticiones.



03 Elevación de pierna recta con resistencia leve.

Igual que el Día 3, agregando un peso liviano en el tobillo si tenés (botella de agua, por ejemplo). 10 por lado.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

Progresá primero el rango de movimiento, después el peso.

DÍA 5

El puente fuerte

Glúteo medio en acción · 15 minutos

Combinar fortalecimiento de cadera y rodilla es más efectivo que trabajar solo la rodilla, especialmente en dolor anterior.

EJERCICIOS

01 Almeja (clamshell).

De costado, rodillas dobladas y juntas, abrí la rodilla de arriba como una almeja, sin mover la cadera hacia atrás. 12 por lado.



02 Puente a una pierna.

Como el puente de glúteo, pero con una pierna estirada en el aire. Si es muy difícil, hacé el asistido (pie apoyado, leve). 8 por lado.



03 Abducción de cadera de pie.

Apoyada en una pared o silla, levánta la pierna hacia el costado, controlada, sin inclinar el torso. 10 por lado.



SI TENÉS PERFIL D (CADERA LATERAL)

Hacé estas isometrías despacio y sin rebote -el tendón del glúteo responde mejor a carga lenta que a movimientos rápidos. Mantené la intensidad bien por debajo de la del resto de los ejercicios, y frená ante cualquier dolor.

DÍA 6

Paso firme

Patrones funcionales · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Step-up bajo controlado.

Subí a un escalón bajo con una pierna, bajá controlada. 8 por lado.



02 Equilibrio en una pierna.

Cerca de un apoyo, sostené el equilibrio en una pierna 20-30 segundos. 2 por lado.



03 Sentadilla parcial con foco en alineación.

Igual que el Día 4, prestando atención a que la rodilla no se vaya hacia adentro.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

Si la rodilla se desvía hacia adentro al bajar, activá el glúteo (como en el Día 5) antes de empezar la sentadilla.

DÍA 7

Mirá lo que construiste

Repaso y flujo combinado · 15 minutos

Esta semana trabajaste control motor y activación. Hoy es revisión, no exigencia nueva.

EJERCICIOS

01 Flujo combinado.

Encadená 3 ejercicios que más sentiste esta semana (uno de activación, uno de fuerza, uno funcional) en un solo flujo de 12 minutos.

02 Reflexión escrita.

Respondé por escrito: ¿qué mejoró? ¿qué movimiento le tenías más miedo y ya hiciste esta semana?

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

El objetivo de esta fase no es "no doler" -es moverte con más confianza que la semana pasada.

DÍA 8

La potencia

Más rango, más fuerza · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Sentadilla con mayor rango.

Baja un poco más que el Día 4, hasta donde sea cómodo, sin dolor agudo.



02 Abducción de cadera de pie con resistencia leve.

Igual que el Día 5, con banda elástica si tenés.



03 Step-up con mayor altura.

Si tolerás bien el Día 6. 8 por lado.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

Regla de las 24 horas. Si al día siguiente te duele más que antes de entrenar, baja un escalón de intensidad la próxima sesión -no es un retroceso, es ajustar la dosis.

DÍA 9

Cadena completa

Cuádriceps y glúteo combinados · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Sentadilla con pausa isométrica.

Baja a tu rango cómodo y sostené 5 segundos antes de subir. 8 repeticiones.



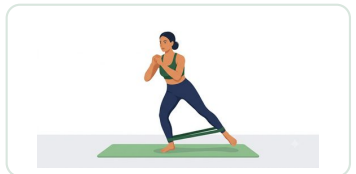
02 Puente con marcha.

En puente de glúteo sostenido, levanta una rodilla y después la otra, alternando, sin que la cadera caiga. 10 por lado.



03 Paso lateral con resistencia leve.

De pie, banda elástica en los tobillos (opcional), pasos laterales cortos. 10 por lado.



SI TENÉS PERFIL D (CADERA LATERAL)

En el paso lateral, mantené el rango chico -la activación de glúteo importa más que la distancia del paso. Hacelo con mucha menos intensidad que los demás ejercicios del día, y frená si sentís dolor.

DÍA 10

Resistencia funcional

Resistencia y constancia · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Wall sit progresivo.

Espalda apoyada en la pared, sentadilla sostenida en tu rango cómodo. 3 series de 15-20 segundos.



02 Step-up de mayor altura.

Como el Día 8, sumando una repetición más por serie si lo tolerás.



03 Equilibrio en una pierna con ojos cerrados.

Cerca de un apoyo. 15 segundos por lado.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

La propiocepción -el sentido de posición de tu articulación- se entrena, no es algo fijo de nacimiento.

FASE 3

La Libertad

Días 11 a 14

La última fase no es el final —es el comienzo de tu nueva normalidad. Integramos todo lo aprendido en movimientos reales y trabajamos directamente sobre el miedo al movimiento.

En esta fase:

- Día 11 — Moverse sin miedo
- Día 12 — Resistencia real
- Día 13 — Mente y movimiento
- Día 14 — La libertad

3

DÍA 11

Moverse sin miedo

Exposición gradual · 15 minutos

La exposición gradual a movimientos temidos —con apoyo, de forma controlada— reduce tanto el miedo como la percepción de dolor, según la evidencia en dolor crónico de rodilla y cadera.

EJERCICIOS

01 Escaleras controladas.

Subí y bajá escaleras de forma controlada, un poco más que tu rutina habitual.



02 Sentadilla completa controlada.

Hasta donde tu cuerpo lo permita sin dolor agudo.



03 Caminata extendida.

Una caminata algo más larga que la que venís haciendo.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

Anotá qué movimiento te genera más miedo hoy, y elegilo como tu "exposición" de esta semana -en pequeñas dosis, con control.

DÍA 12

Resistencia real

Más tiempo, más distancia · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Caminata sostenida.

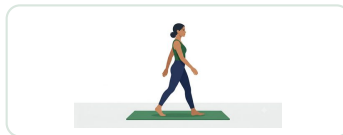
Un poco más larga que el Día 11.

02 Sentadilla funcional.

Practicá sentarte y levantarte de una silla varias veces, con control.

03 Combo de fuerza.

Combiná dos ejercicios de fuerza de la Fase 2 que ya domines bien.



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

La meta no es la velocidad, es completar el movimiento con confianza.

DÍA 13

Mente y movimiento

Integración del trabajo nervioso · 15 minutos

EJERCICIOS

01 Sentadilla con respiración consciente.

Baja inhalando, subí exhalando, despacio.



02 Mapa del miedo.

Listá los movimientos que evitabas al empezar el programa y marcá cuáles ya hiciste.

03 Movimiento cotidiano.

Elegí un movimiento cotidiano que te costaba (agacharte, levantarte del piso) y practicalo con calma.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

El dolor que pueda quedar no equivale a daño -es información de un sistema nervioso que todavía está aprendiendo a calmarse.

DÍA 14

La libertad

Cierre y rutina para siempre · 15 minutos

Llegaste al final del protocolo. Esto no termina acá —es la base de tu rutina de mantenimiento.

EJERCICIOS

01 Elegí tu rutina de mantenimiento.

Elegí 5 ejercicios de los que más sentiste en estas dos semanas (un isométrico, dos de fuerza, uno funcional, uno de exposición) y sosténlos 2 a 3 veces por semana.

DÍA 14

La Libertad

Recordá: si en algún momento aparecen las señales de alarma de la primera página, pará y consultá a tu médico. El programa acompaña tu proceso, no lo reemplaza.

“Gracias por confiar en este método. La biología del dolor está del lado de tu recuperación.”